Clinique Saint-Luc
Bouge

Centre d'étude des troubles du sommeil et de la vigilance

Bilan d'hypersomnie

DATE : 21/09/2026 et 22/09/2026

PATIENT : ANDRES CHRISTINE PAULA

Numéro d'identification : 1229294

Né(e) le : 08/09/1988 Age : 38 ans Chambre 411

Poids : 78 kg Taille : 169 cm BMI : 27.3 kg/m^2

Motif de l'examen : Réévaluation d'une narcolepsie

Médecin demandeur : Dr Dusart – K. Collet

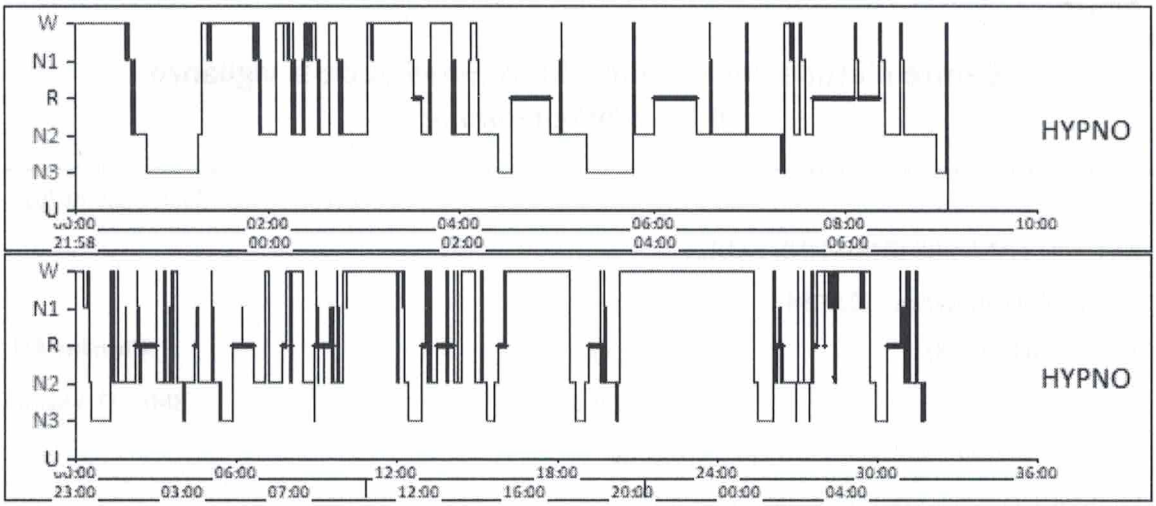
Enregistré par : ADELINE Analysé par : KC

1. Résumé des temps de sommeil

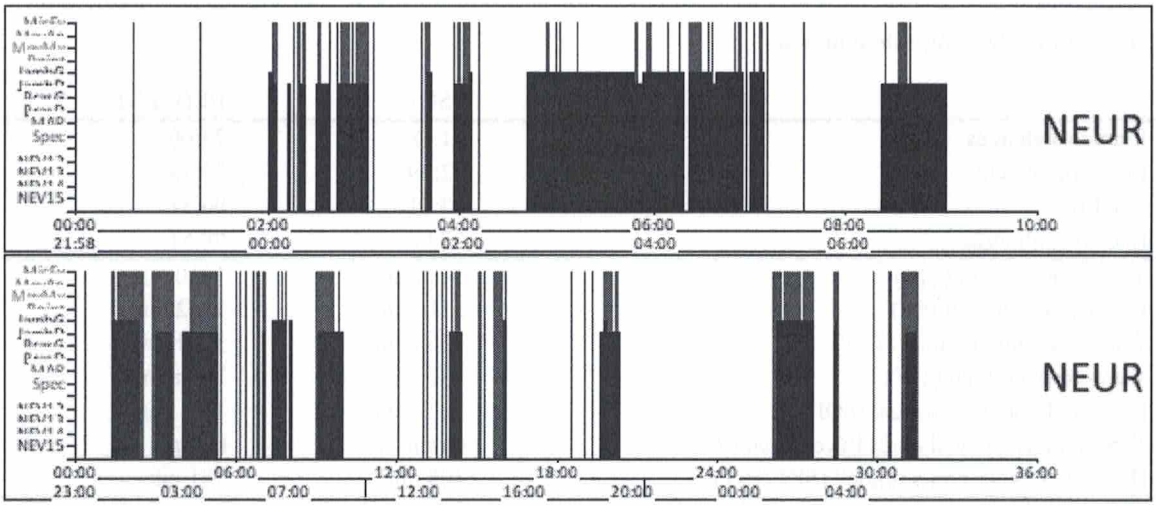
	PSG1	BEDREST
Lumières éteintes	21:58	23:00
Endormissement	22:29	23:18
Eveil final	07:01	06:51
Lumières allumées	07:02	06:51
Temps passé au lit (TIB)	543 min.	1910 min.
Période de sommeil (SPT)	511 min.	1892 min.
Temps de sommeil total (TST)	406 min.	**1111 min.**
Temps d'éveil total (TWT)	137 min.	799 min.
Latence d'endormissement (SOL)	31.5 min.	18.5 min.
Temps passé en éveil après l'éveil final (WAFA)	0 min.	0 min.
Durée de l'éveil intra-sommeil (SPT-TST)	105 min.	781 min.
Indice d'efficacité du sommeil (TST/TIB)	74.7%	58.2%
Indice de continuité du sommeil (TST/SPT)	79.5%	58.7%
Indice de qualité du sommeil (N3+REM/TST)	42.1%	44.7%

Temps passé en…	**en min.**		**en % du TST**	
	PSG1	BEDREST	PSG1	BEDREST
Stade N1	31	79	7.7	7.2
Stade N2	204	535	50.2	48.1
Stade N3	76	225	18.8	20.3
Stade REM	94	271	23.2	24.4

Latences	**en min.**	
	PSG1	BEDREST
Stade N1	31.5	18.5
Stade N2	34.5	30.0
Stade N3	44.5	36.0
Stade REM	211.5	78.5



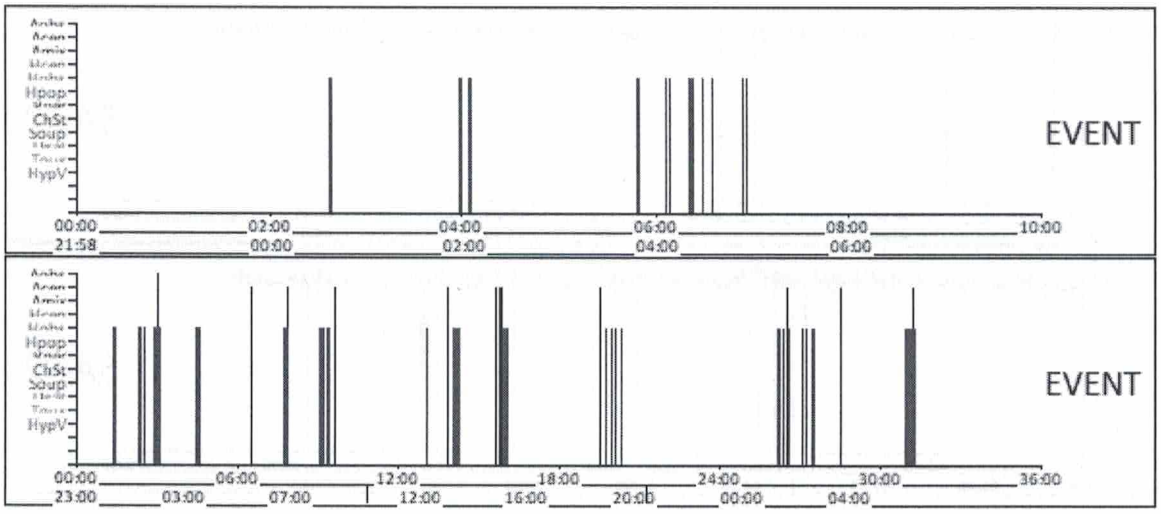
2. Evénements neurologiques



	PSG1	BEDREST
Nombre d'éveils	30	67
Nombre de changements de stade	108	274
Nombre de micro-éveils	98	321
Index de micro-éveils	14.5/h	17.3/h
Index d'éveils + micro-éveils	18.9/h	20.9/h

Index de mouvements… (/h)	PSG1	BEDREST
Des membres inférieurs	76.5	55.5
Périodiques des membres inférieurs	**76.5**	**55.5**
Des membres inférieurs associés à un micro-éveil	0.0	0.0
Des membres inférieurs associés à une apnée/hypopnée	0.0	0.0

3. Evénements respiratoires

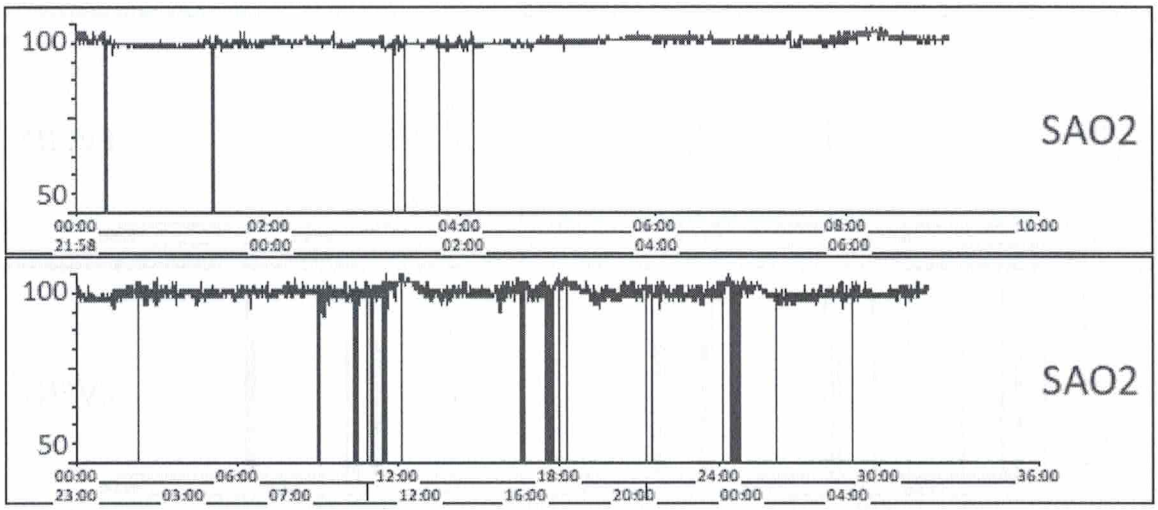


	PSG1	BEDREST
Index d'apnées/hypopnées sur le dos	7.5/h	7.7/h
Index d'apnées/hypopnées pas sur les dos	0.2/h	3.0/h
Index d'apnées/hypopnées en sommeil NREM	2.5/h	3.3/h
Index d'apnées/hypopnées en sommeil REM	3.2/h	8.0/h

	Nombre		Durée moy. sur la nuit (s)		Index (TST)	
	PSG1	BEDREST	PSG1	BEDREST	PSG1	BEDREST
Apnées obs.	0	1	-	13.0	0.0/h	0.1/h
Apnées cen.	0	11	-	13.5	0.0/h	0.6/h
Apnées mix.	0	0	-	-	0.0/h	0.0/h
Hypopnées	0	0	-	-	0.0/h	0.0/h
Hypopnées obs.	18.0	72.0	17.5	17.5	2.7/h	3.9/h
Hypopnées cen.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0/h	0.0/h
TOTAL	18	84	17.5	16.9	2.7/h	4.5/h

Description du ronflement: .
Particularité de la respiration (limitation de débit ? CSB ?): .

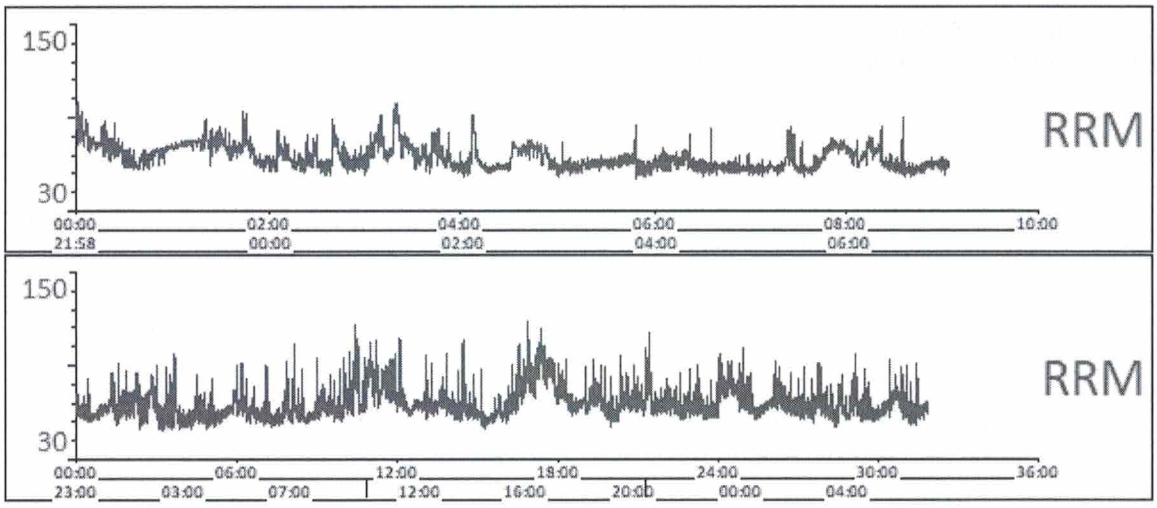
4. Saturation en Oxygène



	SAO2 minimale (%)		SAO2 maximale (%)		SAO2 moyenne (%)	
	PSG1	BEDREST	PSG1	BEDREST	PSG1	BEDREST
Eveil	56.0	52.9	99.0	100.0	95.3	95.5
Sommeil Non REM	93.0	91.0	99.0	99.0	95.5	95.1
Sommeil REM	93.0	71.8	99.0	98.0	96.0	94.8
Sommeil total	93.0	71.8	99.0	99.0	95.6	95.0

	PSG1	BEDREST
Temps passé en dessous de 90% de saturation	0 minutes	0 minutes
Pourcentage de l'enregistrement passé sous 90% de saturation	0.0 %	0.0 %
Nombre de désaturations durant la nuit	17	157
Index de désaturations durant la nuit	1.9/h	4.9/h
Index de désaturations durant le sommeil	2.5/h	8.5/h

5. Rythme Cardiaque



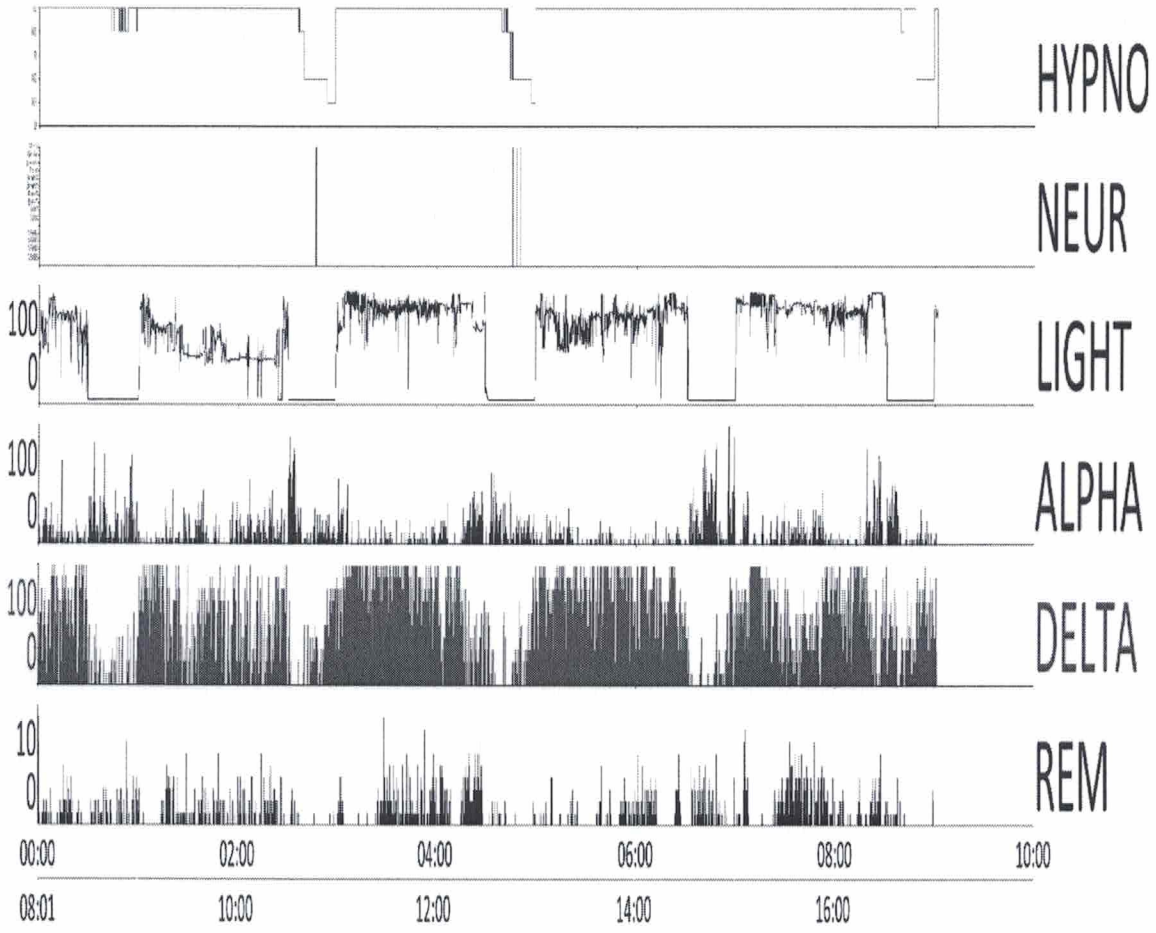
Particularité de l'ECG : .

6. Test itératif de latence d'endormissement

Heure	Sieste 1	Sieste 2	Sieste 3	Sieste 4	Sieste 5
Début de l'enregistrement (lumière éteinte)	08:31	10:31	12:32	14:32	16:32
Endormissement	08:43	10:37	12:40	--:--	16:40
Fin de l'enregistrement (lumières allumées)	09:01	11:03	13:02	15:02	17:02
Latences	**Sieste 1**	**Sieste 2**	**Sieste 3**	**Sieste 4**	**Sieste 5**
Stade N1	12.0	5.5	8.0	20	8.3
Stade N2	-	9.0	13.0	-	17.3
Stade N3	-	23.0	25.5	-	-
Stade REM	-	-	-	-	-
Endormissement	12.0	5.5	8.0	20	8.3

Latence d'endormissement moyenne : 10,8 minutes

Une latence moyenne d'endormissement inférieure à 8 minutes est anormale (sensibilité 94,5%, spécificité 73,3%), une latence inférieure à 5 minutes est franchement pathologique. La présence de sommeil paradoxal à plus d'un test est anormale. La latence d'endormissement est définie comme la durée entre l'extinction des lumières et le premier stade de sommeil (N1, N2, N3 ou REM).



7. Evaluation cognitive des fonctions attentionnelles

Epreuves :	Durée (min)	Médiane TR	Ecart-type TR	Erreur	Omission
Alerte phasique (sans avertisseur)	4.5	**281 (18)**	**39 (50)**	-	0
Alerte phasique (avec avertisseur)		**273 (14)**	**50 (31)**	-	0
Attention soutenue (forme)	0-5	509 (50)	81 (69)	0 (>66)	1 (54)
	5-10	560 (50)	62 (90)	1 (42)	4 (18)
	10-15	572 (46)	117 (50)	0 (>42)	7 (4)
	TOTAL	555 (50)	91 (79)	**1 (79)**	**12 (10)**
Flexibilité, alternance forme		**487 (90)**	106 (73)	**6 (16)**	-
Vigilance	0-15	1045 (5)	268 (21)	0 (>66)	4 (42)
	15-30	1365 (7)	127 (58)	1 (>54)	6 (31)
	TOTAL	1269 (4)	256 (27)	**1 (>76)**	**10 (16)**
Go/No Go	3	**433 (31)**	73 (46)	**0 (>62)**	0 (>14)

Batterie informatisée T.E.A. (Zimmermann et Fimm) ; TR = Temps de réaction en milliseconde ; () = Norme standardisée en centile.

Patient : ANDRES CHRISTINE PAULA Né(e) le 08/09/1988 Examen du 21/09/2026 et du 22/09/2026

8. Agenda du sommeil

AGENDA DE VIGILANCE ET DE SOMMEIL

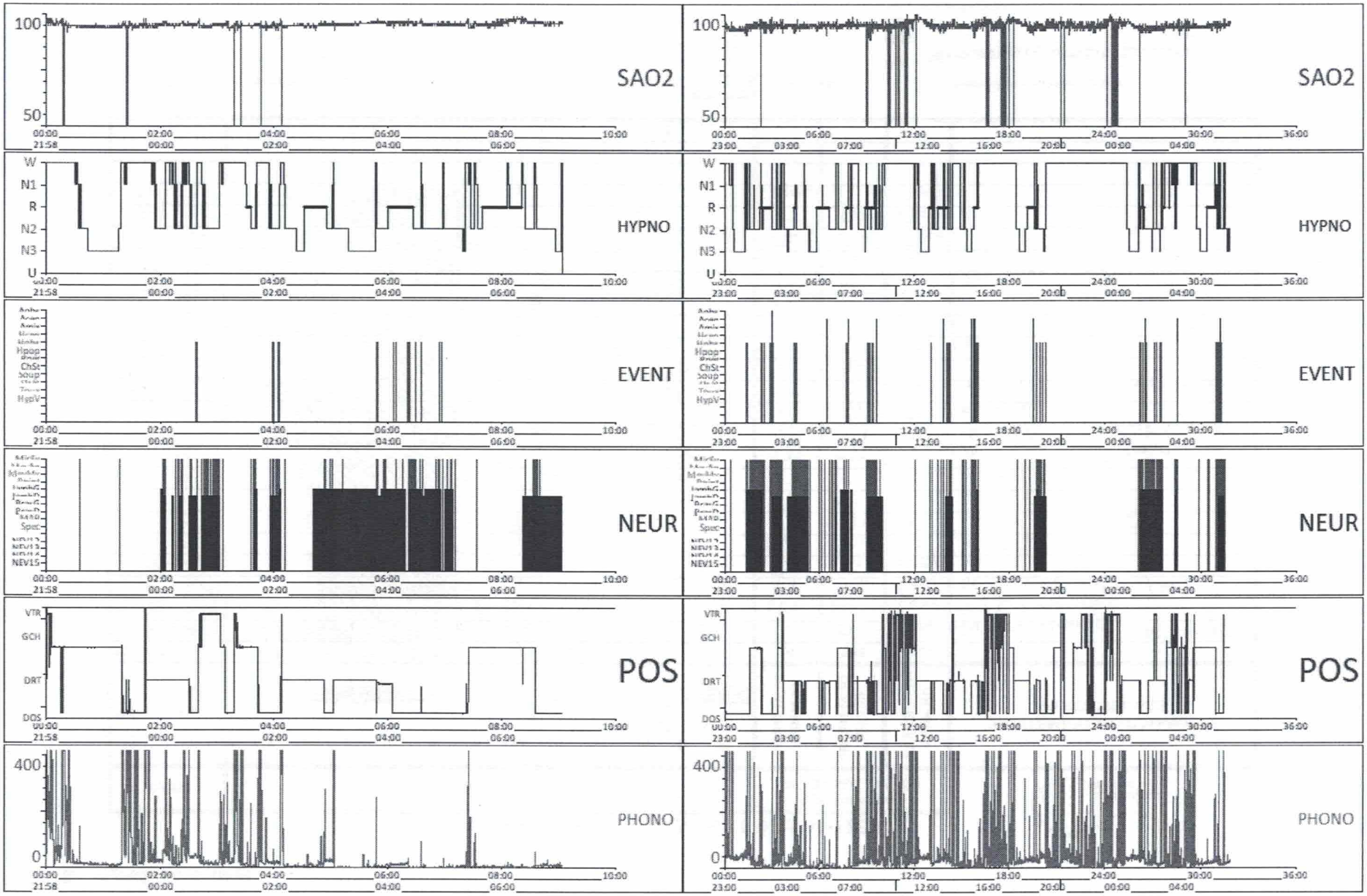
Réseau Morphée

DATE	HEURES (Nuit du ... au...)	Appréciation par : TB - B - Moy. - M - TM			
		QUALITE DU SOMMEIL	QUALITE DU REVEIL	FORME DE LA JOURNEE	TRAITEMENT ET REMARQUES PARTICULIERES
EXEMPLE	↓ … ↑ S S	M	TM	Moy	
31/8 0/9	↓ … S S … S	non	TM	Nay	enfant réveillé ** (soir) / C MAL TÊTE
1/9 - 2/9	S ↓ … S S … S	Nay	Nay	Nay	* / C / MAL TÊTE
2/9 - 3/9	↓ … S S S … S	non	non	Nay	enfant réveillé / * / C
3/9 - 4/9	↓ … S S S … S	Nay	non	Nay	* / C
4 - 5	↓ … S S S	Nay	Nay	non	* / C
5 - 6	↓ … S S S S	non	TM	non	* / C / mauvais
6 - 7	S ↓ … S S S S S	Nay	non	non	** / C
7 - 8	↓ … S S S S S S S	non	non	non	** / C
8 - 9	↓ … S S S S S	TM	TM	non	** / C / très mal dormi
9 - 10	S ↓ … S S S S S	TM	TM	TM	** / C / enfant réveillé
10 - 11	↓ … S S S	non	non	non	** / C
11 - 12	↓ … S S S S R S S S	TM	TM	TM	mal au dos nuit / journée
12 - 13	↓ … S S S	non	Nay	non	
13 - 14	S ↓ … S S S S S S S S	non	non	TM	enfant dans lit, fatigué pleurs
14 - 15	↓ … S S S S S	non	non	Nay	
15 - 16	↓ … S S S S	Nay	non	non	
16 - 17	↓ … S S S S S	TM	TM	non	enfant réveillé
17 - 18	S ↓ … S S	Nay	non	Nay	
18 - 19	↓ … S S S S	Nay	Nay	Nay	
19 - 20	↓ … S S	TM	TM	Nay	
20 - 21	↓ … S S	Nay	non	Nay	

↓ heure de mise au lit
sommeil ou sieste
↑ heure du lever
long réveil
R R R réveil
S Somnolence dans la journée

* PANTOPRAZOLE 1 VIAL 1 FOIS 2X / JOUR
** " " 1X / JOUR
C = Concerta

Patient : ANDRES CHRISTINE PAULA Né(e) le 08/09/1988 Examen du 21/09/2026 et du 22/09/2026



9. Conclusion

Madame ANDRES CHRISTINE PAULA a séjourné au sein de notre unité du sommeil dans le cadre d'un bilan d'hypersomnie. Ce bilan a compris la réalisation préalable d'un agenda du sommeil. Ceci fut suivi d'une double polysomnographie, d'un test itératif de latence d'endormissement (TILE) et d'une évaluation cognitive des fonctions attentionnelles et d'un bedrest (procédure standardisée de 32 heures où le patient dort *ad libitum*).

L'**agenda du sommeil** a été complété durant 21 jours consécutifs. L'heure de coucher varie entre 22h00 et 00h00. L'endormissement est le plus souvent renseigné comme normal. Le sommeil est le plus souvent continu et de durée régulière et normale. L'heure de lever varie entre 7h00 et 10h00. Le temps passé au lit est dès lors évalué à 8h48 en moyenne par nuit pour un temps de sommeil estimé quant à lui à 8h00 en moyenne. L'efficacité du sommeil avoisine en conséquence les 91 %. A cela s'ajoute en journée des épisodes de somnolence diurne excessive ainsi que des siestes irrégulières dont la durée est variable (entre 30 et minutes et 2.5 heures).

La **première polysomnographie** objective une latence d'endormissement normale (14 minutes). On n'observe pas la survenue précoce de sommeil paradoxal après l'endormissement. Le temps de sommeil est de 406 minutes (6h46). L'architecture du sommeil est perturbée par une fragmentation et instabilité excessive. On dénombre 30 éveils complets et 108 changements de stade de sommeil. L'index d'éveils/micro-éveils est de 18.9/h de sommeil. Le temps passé en sommeil lent profond est de 76 minutes (soit 18.8 % du temps de sommeil total). Le temps passé en sommeil paradoxal est de 94 minutes (soit 23.2 % du temps de sommeil total). L'évaluation subjective du sommeil (questionnaire de Spiegel) suggère que cette nuit n'est pas représentative des nuits habituelles. La patiente rapporte avoir très mal dormi et durant un temps moyen. Elle estime avoir mis un temps moyen pour s'endormir et s'être très souvent réveillée en cours de nuit.

Le **test itératif de latence d'endormissement** (TILE) qui a suivi n'objective pas d'hypersomnie. La latence moyenne d'endormissement est strictement supérieure à 8 minutes (10,8 minutes). Absence de survenue précoce de sommeil paradoxal aux siestes réalisées.

L'**évaluation cognitive des fonctions attentionnelles** a été réalisée entre la première et la seconde sieste du TILE. Aucune anomalie majeure n'est mise en évidence. Le profil se caractérisant seulement par des performances se situant dans la norme inférieure, en particulier pour la tâche d'attention soutenue dont le nombre croissant d'omission suggère une fatigue cognitive importante.

La **bedrest** objective une latence d'endormissement normale (20 minutes). On n'observe pas la survenue précoce de sommeil paradoxal après l'endormissement. Le temps de sommeil est de **1111 minutes (18h21 – soit une durée strictement inférieure à 19 heures)**. L'architecture du sommeil est perturbée par une fragmentation et instabilité excessive. On dénombre 67 éveils complets et 274 changements de stade de sommeil. L'index d'éveils/micro-éveils est de 20.9/h de sommeil. Le temps passé en sommeil lent profond est de 225 minutes (soit 20.3 % du temps de sommeil total). Le temps passé en sommeil paradoxal est de 271 minutes (soit 24.4 % du temps de sommeil total).

Sur le plan respiratoire, on n'objective pas d'anomalie respiratoire significative. L'index total d'apnées/hypopnées est de 2.7 et 4.5/h de sommeil, respectivement pour la première nuit puis le bedrest. L'oxymétrie nocturne objective une SaO2 moyenne à 95.6 et 95.0 % pour la première nuit et le bedrest. Le temps passé sous 90% de SaO2 est de 0 minute. L'index de désaturation est de 1.9 et 4.9/h d'enregistrement, respectivement pour la première nuit et le bedrest.

Sur le plan moteur, on remarque des mouvements périodiques des membres inférieurs en surnombre. L'index de MPMS est respectivement de 76.5/h pour la première nuit et de 55.5/h pour le bedrest.

Les **questionnaires psychométriques** complétés suggèrent :

- L'existence d'un trouble anxieux (HAD-A = 11)
- L'existence d'un trouble de l'humeur (HAD-D = 13)
- L'existence de somnolence diurne excessive (Echelle de somnolence d'Epworth à 18/24)
- L'existence de symptômes d'insomnie (Index de sévérité de l'insomnie à 17/28 – liés aux symptômes diurnes essentiellement)
- L'existence d'une claustrophobie (Totale = 54 ; Suffocation = 21 ; Restriction = 33)

- Plaintes : réveils de fin de nuit et sensation de ne pas dormir, somnolence diurne excessive, impression d'être réveillée quand elle dort avec rêves intenses, agitation nocturne, mal de tête au réveil, douleurs éveillantes, sensations désagréables dans les jambes – soulagées par le mouvement – débutant au repos ou l'inactivité, anxiété
- Facteur favorisant : écoute un livre audio pour s'endormir
- Antécédents : TDAH ? Narcolepsie ?

En **résumé**, le bilan ne retrouve pas les caractéristiques de la narcolepsie ou de l'hypersomnie idiopathique : absence de somnolence diurne excessive et/ou d'anomalie du sommeil REM au TILE ; absence d'anomalie de la durée de sommeil au bedrest. Mise en évidence par ailleurs d'un nombre très important de mouvements périodiques des membres inférieurs, associés à une instabilité/micro-fragmentation importante du sommeil.

Nos **recommandations** sont les suivantes :

- La patiente sera revue en consultation par le Dr Dusart afin de discuter des résultats et de la meilleure approche thérapeutique.
- Concernant les mouvements périodiques des membres inférieurs, ceux-ci n'étaient pas associés à une clinique compatible/typique d'un syndrome de jambes sans repos. Dernier bilan martial mettant en évidence une ferritine à 57 mcg/l.
- Échelle psychométrique par ailleurs hautement évocatrice d'une symptomatologie d'un trouble anxiodépressif.

Bien confraternellement,

Dr P. BACHEZ Pneumologue	Dr R. FROGNIER Pneumologue	**Dr DUSART** Pneumologue	Dr P. LEGROS Somnologue
Dr C. REDANT Neurologue	Dr V. MASSANT Psychologue	**K. COLLET** Psychologue	C. LIBOIS Psychologue
V. PARMENTIER Psychologue	R. COLLOT Kinésithérapeute	A. LEJEUNE Infirmière	M. MARNEFFE Technologue
C. THIRY Infirmière	K. TAHIR Technologue	V. DELTHUY Infirmière	